

タイトル: 救急部門臨床医における認知負荷と意思決定疲労

著者: Margaret O. Whitfield (オックスフォード大学 実験心理学科)

概要

救急部門の臨床医は、1シフトあたり数百件の時間的制約のある意思決定を行い、時間経過に伴う意思決定の質の低下が懸念されている。本研究は、救急医と看護師84名を対象に、シフト経過に伴う診断精度と意思決定のレイテンシを測定する。

1. はじめに

長時間の意思決定の後に意思決定の質が低下する意思決定疲労は、司法や仮釈放の場面で報告されている。誤りが即座に結果をもたらす急性期の臨床ケアにおいて同様の効果が現れるかは、これまで十分に検討されていない。

2. 方法

参加者は12時間シフトの開始時、中間点、終了時に、標準化されたトリアージシナリオのバッテリーを実施した。各シナリオについて診断精度、反応レイテンシ、自己報告による認知負荷を記録した。

3. 結果

診断精度はシフト開始時から終了時にかけて平均11パーセント低下し、最も急激な低下は8時間経過後に観察された。自己報告による認知負荷は精度と負の相関を示した ($r = -0.52$)。6時間経過時点で構造化された10分の休憩を取った臨床医は、有意に低下が緩和された。

4. 議論

これらの知見は、構造化された休憩時間が長時間の臨床シフト中の意思決定の質を維持するための実践的な介入となり得ることを示唆する。すべてのシフト時間を同等に扱う施設の勤務体制方針は、持続的な高負荷の意思決定が持つ累積的な認知コストを過小評価している可能性がある。